

Evaluacion Inicial

Protocolo TCC para Depresion Mayor

Nombre del paciente:

Fecha:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Derivado por:

Modalidad: ☐ Presencial ☐ Virtual

Motivo de consulta

Descripcion del motivo de consulta (en palabras del paciente):

Inicio y evolucion de los sintomas:

Factores precipitantes identificados:

Sintomas actuales (marcar los presentes en las ultimas 2 semanas)

☐ Animo deprimido

☐ Perdida de interes/placer

☐ Cambios en peso/apetito

☐ Insomnio / hipersomnia

☐ Fatiga o perdida de energia

☐ Agitacion psicomotora

☐ Sentimientos de inutilidad

☐ Dificultad para concentrarse

☐ Ideas de muerte o suicidio

Intensidad promedio del animo deprimido en la ultima semana (0 = ninguno / 10 = maximo):

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Areas de vida mas afectadas (trabajo, familia, pareja, salud, otro):

Evaluacion de riesgo suicida

SIEMPRE evaluar aunque no este referido espontaneamente.

☐ Sin ideacion actual	☐ Ideacion pasiva	☐ Ideacion activa sin plan
☐ Plan concreto	☐ Intentos previos	☐ Acceso a medios

Observaciones sobre riesgo (factores protectores, red de apoyo):

Historia clinica relevante

Episodios previos de depresion o tratamientos anteriores:

Antecedentes familiares relevantes:

Medicacion actual:

Enfermedades medicas activas:

Formulacion de caso

Triada cognitiva identificada (vision de si mismo, mundo, futuro):

Hipotesis de mantenimiento del problema:

Recursos y fortalezas del paciente:

Objetivos y plan de tratamiento

Objetivos terapeuticos acordados:

Frecuencia de sesiones:

Duracion estimada:

Observaciones adicionales:

Registro de Sesión

Protocolo TCC para Depresión Mayor

Paciente: _____ Fecha: _____ Sesión N: _____ Fase: E / I / C _____

Estado al inicio

Nivel de ánimo deprimido al inicio (0-10):

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Como estuvo la semana? Que fue lo mas significativo?

Revisión de tareas

☐ Tareas realizadas	☐ Parcialmente realizadas	☐ No realizadas
--	--	--

Observaciones sobre las tareas:

Contenido de la sesión

Temática central trabajada:

Desarrollo de la sesión (técnicas, diálogos, intervenciones clave):

Pensamientos o creencias emergentes relevantes:

Respuesta del paciente

☐ Participación activa	☐ Resistencia moderada	☐ Dificultad para conectar
---	---	---

Observaciones sobre respuesta emocional y conductual:

Nivel de animo al FINAL de la sesion (0-10):

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Plan para la proxima sesion

Tematica prevista:

Tareas acordadas:

Alertas clinicas (ideacion suicida, deterioro, otro):

Seguimiento y PHQ-9

Revision de progreso — completar cada 4 sesiones

Paciente:

Fecha:

Sesiones completadas:

Fase actual:

PHQ-9 — Cuestionario de Salud del Paciente

Pregunta	Nunca (0)	Varios días (1)	Mas de la mitad (2)	Casi siempre (3)
1. Poco interes o placer en hacer cosas				
2. Sentirse triste, deprimido o sin esperanza				
3. Dificultad para quedarse dormido, o dormir demasiado				
4. Sentirse cansado o con poca energia				
5. Poco apetito o comer en exceso				
6. Sentirse mal consigo mismo o que ha fallado a su familia				
7. Dificultad para concentrarse en cosas como el trabajo				
8. Moverse o hablar tan lento que otros lo notaron; o lo contrario				
9. Pensamientos de que estaria mejor muerto				

0-4 = Minima | 5-9 = Leve | 10-14 = Moderada | 15-19 = Moderada-Severa | 20+ = Severa

TOTAL: ____ / 27

Puntaje en sesion anterior:

Diferencia:

Avance en objetivos terapeuticos

Objetivo	Progreso (0-10)	Observaciones

Ajustes al plan de tratamiento:

Proximos pasos:
